EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 78812
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 12-02-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: INES DEL CARMEN SEPULVEDA SEPULVEDA			RUN	: 4.821.638-2
F.Nac	: 15-04-1939	Edad	: 84 AÑOS, 9 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: LOS GALPONES			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 934072432		
Fecha Ingreso	: 2024-02-07	Fecha Egreso	: 12-02-2024	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

IDX:
Sepsis foco urinario:
-Hemocultivo (+) Proteus mirabilis BLEE
AKI KDIGO II sobre ERC
AP: Institucionalizada, DHCxOH CHILD B, HTA, Hipotiroidismo.

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. A41.9-SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente ingresado en contexto de síndrome febril prolongado asociado a CEG. Se valoran exámenes de laboratorio donde impresiona proceso infeccioso en ascenso. En vista de cuadro febril, desde ingreso, se solicita HC que reporta positivo para P. mirabilis BLEE. Se toma muestra de orina (sin EOC solo UCT) que evidencia positivo para P. mirabilis. Se considera cuadro infeccioso severo como causal de ingreso.
Para ingreso paciente en regulares a malas condiciones generales, eupneica, afebrl, taquicárdica. Destaca compromiso de consciencia sobre basal, (somnoliente) con GSW 13-14 pts. En vista de resultado de cultivos se decide iniciar con terapia ATB dirigida según antibiograma. Control con ex lab en 48h. Se conversa caso con familiar durante valoración comentándole condición actual de paciente.
Para el 11/02 Impresiona: Disminución de parámetros inflamatorios (PCR 199->83, GB 9->6.4), mejoría en función renal (crea 2.0 -> 1.4), con persistencia de plaquetopenia. Franca mejoría clínica, paciente consciente, orientada, sin signos de focalización o irritación meníngea, más conectada con el medio. Se conversa con familiares.
En vista de condiciones se decide derivación a Hodom para continuidad de terapia.

Ex físico:
Piel: cambios y signos propios de la edad. Llenado capilar límite. Se evidencian múltiples parches equimóticos de predominio en EESS en regresión.
CP: Torax asimétrico, aumento de diámetro AP, escasos estertores bilaterales. RSCSRSRS SS NG.
ABD: distendido, BDI. RHA+
Neurológico: Consciente, orientada, sin signos de focalización o irritación meníngea.
Extremidades: Equimosis descritas. Aumento de volumen en ESI secundario a venopunción difícil, equimosis y extravasación. Aumento de volumen en EEII GI-II. Várices GI-II.

PLAN DE MANEJO:

Infeccioso: Paciente con UCT de ingreso positivo para P. mirabilis. Se recibe HC de positividad temprana para P. mirabilis. Se reajusta terapia acorde a resultados. Se valora RX donde se evidencia patrón intersticial bilateral, sin foco aparente. Parámetros inflamatorios en ascenso desde ingreso (54 ->200). 11/02: franca disminución de parámetros inflamatorios posterior a reajuste de terapia. Nuevo control para 13/02.

Hemodinámico: límite, paciente con presión arterial con tendencia a hipotensión. Recibiendo aporte hídrico (aumentar en contexto de sepsis y falla renal), evitar sobrecarga. Plaquetopenia de larga data (nov 2023 con 70mil plaquetas), actual con 33mil, sin requerimiento transfusional actualmente.

Nefrometabólico: Función renal alterada desde ingreso (crea 2.6), actualmente en descenso (1.4). Buena respuesta a terapia hídrica. Basal de paciente crea 1.1 (noviembre 2023).

INDICACIONES AL ALTA

1. Derivo a HODOM
2. Reposo relativo asistido | PUPP
3. Elevación de EESS | Frio local
4. Regimen liviano, hiposódico a tolerancia. Hidratacion abundante VO
5. Omeprazol 40mg ev día
6. Heparina 5000 UI SC c12h
7. Meropenem 1gr c12h ev (4/7)
8. Levotiroxina 100mcg vo día
9. Lactulosa 10 cc vo c8h (Titular para 2-3 deposiciones/día)
10. Captopril 25mg SL SOS PA>180/110mmHG
11. Ex lab AM
12. Bromuro ipratropio 4 puff c6h
13. Balance hídrico
14. KNT M
15. Control sv c8h
16. Avisar eventualidad

andres david velasquez guerra
MEDICO TRATANTE
27124399-5

JEFE SERVICIO